Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 7ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0112403-69.2023.8.17.2001**

AUTOR(A): CARLA MARIA DA FONTE DINIZ

RÉU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO RECIFE – SEÇÃO A

Ação Ordinária

Processo nº **0112403-69.2023.8.17.2001**

SENTENÇA

-

EMENTA: PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. COBERTURA OBROGATÓRIA EM PLANO DE REFERÊNCIA.

- Atenção à lei 9.656/1998, ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, RN nº 465, de 24/02/2021 e ao PARECER TÉCNICO Nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021.

- Fornecimento de medicamentos de uso hospitalar e ambulatorial – Cobertura. Precedentes do STJ e TJPE: "*Ressalta-se, ainda, que a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, que é o caso dos autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida) (REsp nº 1.927.566/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2021).*

Vistos etc.

CARLA MARIA VIEIRA DA CUNHA DA FONTE**,** qualificada na inicial, por meio de advogado, ingressou com Ação Ordinária em face de BRADESCO SAÚDE S.A., igualmente identificada.

Negando ter interesse na realização de audiência de conciliação, afirmou ser segurada do plano réu, referente ao seguro-saúde Saúde Top, coletivo empresarial, registro da ANS 441999035, Apólice 120684, código TNP4, desde 16/09/2011.

Disse ter sido diagnosticada com Artrite Reumatóide Soronegativa (CID M06), doença autoimune e grave, caracterizada clinicamente por poliartrite ativa, aditiva, envolvendo pequenas articulações de mãos e pés, ocasionando a limitação funcional para realizar atividades da vida diária e profissional, em virtude do comprometimento da movimentação, bem como fortes e constantes dores nas articulações, sendo, ainda, portadora de doença celíaca colite subclínica e antecedente de psoríase.

Afirmou estar seu quadro clínico em atividade, apresentando progresso após o uso de corticoide intravenoso, e, ao longo da realização do tratamento, desenvolveu Síndrome de Cushing, desencadeada pela exposição a níveis elevados de cortisol por um longo período, sendo-lhe prescrito o uso de 02 (duas) doses diárias de 5mg do medicamento de Tofacitinibe (Xeljanz), mas que, negada cobertura pela ré, foi obtida mediante o processo de nº 0042126- 33.2020.8.17.2001, já sentenciado.

Apontou que, com o surgimento da referida síndrome, desenvolveu farmacodermia grave com anti-inflamatórios e alergia aos componentes da Sulfasalazina, substâncias constantemente utilizadas no tratamento contra a Artrite Reumatóide Soronegativa, desenvolvendo, ainda, meningite asséptica, uma síndrome infectocontagiosa estabelecida após inflamação das meninges, contraída em momento posterior à realização da infusão de imunoglobulina, com o fim de reverter o quadro atual, mas sendo seu uso contraindicado pelo médico especializado, o médico reumatologista que a acompanha prescreveu como única possibilidade de tratamento a infusão do medicamento MabThera de 500 mg endovenoso, cuja cobertura foi negada pela ré, sob arguição de que já fornece a medicação Xeljanz.

Pugnou pela concessão de antecipação de tutela a fim a compelir a parte demandada custeie de forma imediata, o tratamento indicado pela médica assistente: "*infusão do MabThera 500 mg, via endovenosa lenta, em 6h e em ambiente hospitalar (HOSPITAL ESPERANÇA), semanalmente) concedido em caráter complementar aos já autorizados*", indicando ser o nosocômio credenciado à ré, e ao final, indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00. Juntou documentos.

Ordem de emenda, com quitação de custas.

Decisão concedendo a medida antecipatória dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré autorize, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o tratamento indicado no laudo médico de id. 144801085/144801086 - infusão do MabThera 500 mg, via endovenosa lenta em 6h e em ambiente hospitalar, semanalmente (id 144990695).

Peça da parte autora noticiando descumprimento da decisão.

Decisão determinando a intimação da parte ré para, no prazo de 48h, demonstrar o cumprimento integral da decisão de Id 144990695, sob pena de bloqueio de valores por meio do Sisbajud e advertindo que o descumprimento poderá ensejar majoração da multa ali estipulada e configurar ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa (id 145615071).

Pedido de a dilação do prazo pela ré (id 146403675).

Concessão de 05 dias para a parte ré demonstrar o cumprimento integral da decisão de id 144990695 (id 146869737).

Contestação aduzindo ter sido negada a medicação porque outra já está sendo fornecida para o mês de setembro, havendo liberação após a comunicação da decisão judicial em 26/09/2023.

Afirmou ser o medicamento pretendido passível de cobertura conforme DUT ANS/RN 465, à patologia da parte autora, apenas sendo solicitado o cancelamento do pedido anterior para acerto de datas.

Defendeu a necessidade de observação do equilíbrio financeiro do contrato e refutou haver danos morais a indenizar. Acostou documentos.

Intimação das partes para indicação de possibilidade conciliatória ou provas a produzir (id 148276951).

Negativa da parte ré.

Réplica expondo estar a realizar todo o seu tratamento no HOSPITAL ESPERANÇA, conveniado e com médicos credenciados, sem pedido de provas (id 152552013).

Peça da ré dizendo que a senha de autorização foi concedida e a segurada iniciou o tratamento com medicamento MABTHERA em 28/09/2023 (id 152724629).

Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, falar sobre documentos de id 152724629, requerendo o que entender de direito (id 153713461).

Certidão de que a parte autora, devidamente intimada do despacho retro, deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos (id 145602138).

É o relatório, passo à decisão.

Cuida-se da hipótese de questão que dispensa dilação probatória, uma vez que os elementos presentes, inclusive a prova documental, já são suficientes para emitir a sentença, tendo as partes negado outras provas a produzir.

No que concerne à arguição de falta de interesse de agir, por não haver a parte provado prévio requerimento administrativo ou tentado acordo em plataformas extrajudiciais de conciliação, rejeito tal alegação em nome do direito de acesso à Justiça pela inafastabilidade.

Resta pacificado em doutrina e jurisprudência pátrias que o Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de plano/seguro de saúde firmados com operadoras que comercializam os pactos

A jurisprudência pátria vem sofrendo para estabelecer decisões em casos de cobertura de procedimentos por contratos de assistência à saúde, pois, de um lado, há toda uma gama de direitos estabelecidos em favor da saúde, personalidade e consumidor, havendo, porém, a necessidade de preservação da viabilidade econômica das empresas que ofertam tais pactos e do equilíbrio das contraprestações.

Para tanto, este juízo tem se amparado das normas que lastram ambas as vertentes e das normativas do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), criado pela Lei 9.656/1998, e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, instituída pela Lei 9.961/00, para regulação e fiscalização das atividades que garantam assistência suplementar.

Ressalto que o Enunciado 33, da I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ, dispõe aos magistrados que atentem para os pareceres técnicos das agências reguladoras:

> "*ENUNCIADO N.º 33 Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar* e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec)** para auxiliar a prolatação de decisão ou a propositura da ação."*

As Diretrizes de Utilização (DUT) são regras e normas elaboradas pela Agência Nacional de Saúde (ANS) que servem para orientação e regulamentação do uso adequado de procedimento médicos e exames complementares, sendo descritas e baseadas em estudos médicos com a finalidade de utilização das novas tecnologias ou exames que realmente possam trazer benefícios para o paciente ou que auxiliem os médicos no diagnóstico de doenças.

Ressalto que o chamado Plano de Referência foi instituído pelo art. 10 da lei 9.656/98 como aquele com "*cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (...)"* (redação da MP 2.177-44/2001).

Afere-se que mesmo o plano de referência não possui cobertura ilimitada, pois há exceções de cobertura no próprio artigo e em regulamentações da ANS.

No caso sob foco, trata-se de contrato Saúde Top, coletivo empresarial, registro da ANS 441999035, Apólice 120684, código TNP4, desde 16/09/2011.

A parte autora manifestou que o procedimento objeto da demanda deverá ser administrado em ambiente hospitalar.

Assim, em sendo medicamento a ser administrado em ambiente ambulatorial ou hospitalar, cabe cobertura em razão da Lei nº 9.656/1998, da RN nº 465[1] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftn1), de 24/02/2021, e do PARECER TÉCNICO Nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021[2] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftn2), esse assim explícito:

> *"COBERTURA: MEDICAMENTOS*

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN n.º 465/2021, vigente a partir de 01/04/2021, estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas.

Conforme as regras descritas a seguir, os medicamentos cobertos devem estar regularizados e/ou registrados e suas indicações devem constar da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante, conforme disposto no artigo 8º, inciso III, da RN 465/2021, à exceção do disposto no artigo 24, da mesma resolução.

Além disso, a Lei n.º 9.656/1998, deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso constantes no Rol vigente (art. 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g").

Assim, à luz das disposições contidas na Lei nº 9.656/1998, e na RN n.º 465/2021, temos as seguintes regras para a cobertura de medicamentos:

(...)

3. Planos de segmentação referência

<u>No plano-referência de assistência à saúde, que contempla a assistência ambulatorial e hospitalar, fica assegurada a cobertura obrigatória para os medicamentos contemplados em ambas as segmentações, ambulatorial e hospitalar</u>."

Ressalto posicionamento recentíssimo do Superior Tribunal de Justiça em caso de medicamento de uso ambulatorial:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

4. <u>A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido.</u>" (STJ - AgInt no REsp: 1989033 DF 2022/0062136-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)" (grifos para destacar)

No voto condutor do referido acordão, o exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator, fez questão de distinguir a falta de cobertura do medicamento de uso domiciliar não oncológico e a necessidade de cobertura do medicamento ambulatorial:

"*Quanto aos medicamentos de uso domiciliar, a decisão agravada ressaltou que a jurisprudência dominante e mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração*

em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). (...)
Ressalta-se, ainda, que a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, que é o caso dos autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida) *(REsp nº 1.927.566/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2021)."* (grifos para destacar)

Assim também o Tribunal de Justiça de Pernambuco em hipótese semelhante:

"Apelação cível. Plano de saúde. Paciente diagnosticado com anemia severa decorrente de sangramento. Prescrição de tratamento com uso do medicamento Ferrinject. Dever de cobertura. Danos morais configurados. Valor indenizatório. Manutenção. Recurso não provido por unanimidade. 1) Cabe aos profissionais de saúde avaliar a situação de saúde de seus pacientes e, com base nisso, indicar-lhes o melhor tratamento. 2) Cabe à Seguradora oferecer aos seus segurados a opção de adaptação dos contratos firmados anteriormente à vigência da Lei 9.656/98. Por conseguinte, somente é possível afastar a aplicação da referida legislação quando o consumidor houver comprovadamente optado por não adaptar o seu contrato. 3) ***Os laudos médicos anexados aos autos justificaram a necessidade do medicamento a ser ministrado em ambiente hospitalar, diante da ausência de controle satisfatório do quadro clínico do paciente, apesar de ele já ter se submetido a tratamento com reposição endovenosa de ferro****. (...)" (TJ-PE - AC: 00452940920218172001, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)" (*grifos para destacar)

*"CIVIL E PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO INTRAVENOSO A SER MINISTRADO EM AMBIENTE AMBULATORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Cobertura de medicamento (ferrinject/1.000mg). Paciente pós gastroplastia. Quadro de anemia ferropriva aguda agravada por metrorragia secundária a endometriose, refratária a tratamento via oral. Risco de transfusão sanguínea. 2.****Tratamento com medicamento intravenoso que é de caráter ambulatorial/hospitalar e foi prescrito pela médica assistente da autora para ser realizado emcaráter de urgênciadiante do seu quadro clínico. 3. STJ:"(...) 3. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).(STJ, AgInt no REsp n. 1.747.463/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022)****" 4. Recalcitrância da seguradora em cumprir a determinação judicial. Consumidora obrigada a lidar com os transtornos causados pela imersão diária na comorbidade que sofre, comintolerância gástrica, constipação, quadro de dor hemorroidária, tonturas, sonolência e prostração, estando a ponto de ser submetida a procedimento muito mais invasivo e complexo de transfusão de sangue. Dano moral verificado na espécie. 5. Importe indenizatório de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença mantido. 6. Apelo da seguradora ao qual se nega provimento. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela BRADESCO SAÚDE S/A, de conformidade com o relatório e voto, que devidamente revistos e rubricados, passam a integrar este julgado. Recife, data da certificação digital. Eurico de Barros Correia Filho Desembargador Relator (TJ-PE - AC: 00664482020208172001, Relator: EURICO DE BARROS CORREIA FILHO, Data de Julgamento: 30/07/2022, Gabinete do Des. Eurico de Barros Correia Filho)"* (grifos para destacar)

Assim, em sendo medicamento de administração hospitalar, deve ser coberto pelo demandado, conforme laudo médico.

Com lastro no entendimento pacificado no STJ e no TJPE, entendo haver dano moral pela negativa indevida de medicamento de uso ambulatorial, pois atingidos direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio moral e, dependendo da situação prescinde a sua demonstração em juízo (*in re ipsa).*

Maria Celina Bodin de Moraes conceitua dano moral como:

> *"[...] Aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos. Isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais entre outros. O dano ainda é considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, origina angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas".**[3]** (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftn3)*

Flavio Tartuce assim se coloca:

> "*A melhor corrente categórica é aquela que conceitua os danos morais como lesão a direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira. Alerte-se que para a sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo. Por isso é que se utiliza a expressão reparação e não ressarcimento para os danos morais.*"[4] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftn4)

Nesse sentido a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

> "Essa é outra questão que enseja alguma polêmica nas ações de indenização. Como, em regra, não se presume o dano, há decisões no sentido de desacolher a pretensão indenizatória por falta de prova do dano moral.
>
> Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação, através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorna à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.
>
> Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do

próprio fato ofensivo de tal modo que provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada a perda de um filho, do cônjuge, ou de outro ente querido, não há que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de acordo com as regras de experiência comum; provado que a vítima teve seu nome aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral."**[5]** (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftn5)

Especificamente ao caso, coloco que a jurisprudência do STJ vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada[6] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftn6).

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco observa restar configurado o dano moral, pelo sofrimento e abalo psíquico-econômico experimentado pelo paciente, ao ser desprotegido pelo plano em momento de grande fragilidade física e emocional[7] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftn7).

No tocante ao valor da indenização, entendo que conferir valor ao dano moral é tarefa árdua, eis que não se pode valorar a dor da agressão ao direito de personalidade imposta a alguém, assim, a jurisprudência pátria tem fixado parâmetros de modo a se ter uma compensação amenizadora, não irrisória e nem exacerbada.

Entendo, porém, que o valor da indenização deve ser adequado às peculiaridades do fato em questão, atendendo à repercussão do dano na esfera íntima do ofendido, às circunstâncias do fato em si, sua extensão.

No caso sob foco, ressaltando os fatos acima já narrados, e levando em consideração, outrossim, o potencial econômico-social do ofensor, de forma a inibir tal comportamento, ou seja, verdadeiro *desestímulo* a ponto de demovê-lo de novas práticas lesivas da mesma espécie ou diversa, tendo caráter não punitivo, mas pedagógico.

Adoto esse entendimento, ressalto, sob o exemplo do Superior Tribunal de Justiça, quando em seus julgados em que ressalta o caráter pedagógico do dano moral, visando exatamente o que dito acima, inibir outros comportamentos lesivos de igual forma (*EREsp 748868/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 25/03/2009, DJe 06/04/2009 / Esp 910794/RJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, j. 21/10/2008, DJe 04/12/2008 - REsp 763531 / RJ SEGUNDA TURMA Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS25/03/2008 DJe 15/04/2008*).

Assim, diante de tudo que foi acima exposto, considerando que a parte autora ficou sem cobertura, indevidamente, fixo em R$ 4.000,00 o valor a ser indenizado.

Ante o exposto, com fulcro na legislação acima colocada, **julgo procedente o pedido,** para:

a) condenar a parte ré à cobertura de infusão do medicamento MabThera 500 mg, via endovenosa lenta em 6h e em ambiente hospitalar, conforme laudo médico de id. 144801085/144801086, confirmando a tutela de id 144990695;

b) condenar a parte demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00, acrescidos de correção monetária com base na tabela do ENCOGE e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN), ambos contados a partir desta data, eis que apenas aqui fixado o *quantum* devido (Súmula 362, STJ e REsp nº 888.751 - BA (2006/0207513-3) – DJe 27/10/2011)[8] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftn8);

c) condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor total da condenação (valor orçado da cobertura ao medicamento na inicial, somado ao importe de indenização por danos morais), com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se o pagamento integral das custas processuais da fase de conhecimento e arquivem-se os autos.

Em não tendo ocorrido pagamento das custas, intime-se a parte sucumbente para efetuar o pagamento das custas processuais, no prazo de quinze dias, **sob as penalidades da lei.**

Em não havendo manifestação, à secretaria para efetuar os cálculos dos valores anteriormente mencionados e, em seguida, oficie-se à Procuradoria do Estado, para as devidas providências legais, e à Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Comitê Gestor de Arrecadação, nos termos dos Provimentos nº 007/2019 - CM, de 10 de outubro de 2019, e nº 003/2022-CM, de 10 de março de 2022.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos.

Recife, 08 de fevereiro de 2024.

IASMINA ROCHA

Juíza de Direito

---

[1] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftnref1)Disponível em: < http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDAzMw==> Acesso em 06/04/2021.

[2] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-

%20Mabthera.doc#_ftnref2) Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_21_2021_medicamentos.pdf (https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_21_2021_medicamentos.pdf)> Acesso em 23/08/2023.

[3] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftnref3) MORAES, Maria Celina Bodin de. **Danos à Pessoa Humana**. *Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009, p. 157.*

[4] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftnref4) Tartuce, Flávio. **Manual de direito civi**l: volume único /. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.

[5] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftnref5)CAVALIERI FILHO, Sergio. **Programa de Responsabilidade Civil.** 10ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 97.

[6] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftnref6) REsp 986.947/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11.03.2008, DJ 26.03.2008 p. 1

[7] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftnref7) TJPE – AC 115577-1 – Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio – DJPE 13.06.2007

[8] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20Oncol%C3%B3gico%20-%20Quimioterapia%20%20-%20Rem%C3%A9dio%20N%C3%A3o%20constante%20de%20Rol%20ANVISA%20-%20Off%20Label%20-%20Mabthera.doc#_ftnref8) "Caracterizado o dano moral, mostra-se compatível a fixação da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. Em razão do prolongado decurso do tempo, nesta fixação da reparação a título de danos morais já está sendo considerado o valor atualizado para a indenização pelos fatos ocorridos, pelo que a correção monetária e os juros moratórios incidem a partir desta data."

Assinado eletronicamente por: **IASMINA ROCHA**
08/02/2024 08:05:32
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **160555744**

24020808053221100000156828169

IMPRIMIR GERAR PDF